방광염 — 항생제 전에 소변검사, 그리고 끝까지

방광염은 방광에 세균이 들어와 생기는 흔한 감염으로, 소변 볼 때 따갑거나 갑자기 자주 마려운 증상이 대표적입니다. 검사와 복용 순서를 지키는 것이 정확한 진단과 재발 예방의 핵심입니다.

치료의 원칙 3가지



원칙	실천 방법
1	**항생제를 먹기 전에 소변검사를 받으세요** — 약을 먹은 뒤에는 검사가 부정확할 수 있습니다. 필요하면 배양검사도 함께 하고, 결과가 나오면 더 잘 듣는 약으로 바꿀 수 있습니다.
2	**처방받은 기간(예: 5일) 끝까지 드세요** — 증상이 좋아져도 임의로 중단하지 마세요. 약마다 정해진 기간이 다르므로, 처방받은 대로 끝까지 복용하는 것이 핵심입니다.
3	**물을 많이 마시고 소변을 참지 마세요** — 수분을 충분히 섭취하고, 소변이 마려울 때 습관적으로 오래 참지 않는 것이 회복과 재발 예방에 도움이 됩니다.

흔한 오해 바로잡기

흔한 오해	바로 알기
"소변이 잦으면 콩팥이 나쁜 것"	아닙니다. 빈뇨는 대개 방광의 문제이고, 콩팥까지 번진 경우는 열·옆구리 통증으로 나타납니다.
"주사 항생제 한 방이면 된다"	주사 항생제는 상황에 따라 함께 쓸 수 있지만, 방광염 치료의 기본은 처방받은 기간 동안 먹는 항생제를 다 복용하는 것입니다.

이런 경우는 구분이 필요합니다

신우신염 의심 · 바로 오세요

- **옆구리 통증, 열·오한**이 있으면 신우신염일 수 있습니다. 바로 오세요.
- **메스꺼움·구토**가 함께 있는 경우
- **방광염 약을 먹는데도** 증상이 나아지지 않거나 오히려 나빠지는 경우

몹시 아프거나 상태가 빠르게 나빠지는 경우 — 열이 높고 구토로 약을 못 드시거나 크게 처지면 응급실로

오래된 빈뇨는 다를 수 있음

- **오래된 빈뇨는 염증이 아니라 과민성 방광**일 수 있습니다.
- 새로 갑자기 생긴 배뇨통·빈뇨는 방광염 쪽에 가깝습니다.
- 오래 지속된 빈뇨만으로는 급성 방광염으로 단정하지 않습니다.
- 구분이 애매하면 진료 시 함께 확인하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 요로감염 항생제 사용지침 2018 · IDSA/ESCMID 요로감염 치료지침 2010 · EAU 요로감염 지침 2026 · AUA/SUFU 과민성 방광 지침 2024

본 자료는 일반적인 성인 여성의 단순 방광염 안내입니다. 임신, 재발성 감염, 남성의 요로감염, 신우신염 의심 상황은 검사와 치료 방침이 달라질 수 있으니 진료 시 확인하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/screening/cystitis-uti/